Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

Suspicion d'AVC : bilan IDE en attendant le SAMU

Adulte et enfant · même si les signes ont régressé

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · visage, bras, parole (FAST), **même régressifs** ; perte brutale de la vue, grand déséquilibre, céphalée brutale ; convulsion ; trouble de conscience.

J'applique si

- Signe neurologique brutal (**FAST**), même passager.
- Non communicant : changement brutal de comportement ou de motricité.

Je ne fais pas

- Retarder l'appel : **le 15 avant le bilan complet**.
- **Rien per os**, même le traitement habituel (déglutition non évaluée).
- **Aucun antihypertenseur**, aspirine ou sédatif sans le 15.
- Convulsion : protocole « Crise convulsive prolongée – Midazolam buccal ».

J'agis

ACTES CONSERVATOIRES (R4311-7)

1. **15 immédiatement**, avant le bilan complet (message : carte ci-contre).
2. **Glycémie capillaire** ; < 0,70 g/L : protocole « Hypoglycémie – Resucrage / glucagon » ; le dire au 15.
3. PA **aux deux bras**, FC, SpO2, T°, Glasgow ; **O2 si SpO2 < 95 %**.
4. Décubitus dorsal ; **PLS** si vigilance altérée ou vomissements ; retirer le dentier.
5. Préparer DLU, traitements, dernier INR ; prévenir la famille (enfant : parents, PAI).

RÔLE PROPRE

6. **ECG 12 dérivations** s'il ne retarde pas le départ ; transmis au médecin.

SUR ORDRE DU 15

7. Voie veineuse (NaCl 0,9 %, côté non paralysé), tout médicament, PA très élevée.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Le 15 veut savoir

Heure de **dernière vue normale**

- pas l'heure de découverte

Glycémie · PA aux 2 bras

Anticoagulant : molécule, heure de prise

Autonomie antérieure · DLU · LAT

J'appelle le médecin

- Après le 15 : médecin de l'établissement, d'astreinte ou DOTR informé.
- Maintien sur place décidé par le 15 : prescriptions écrites demandées.

Je surveille et je trace

- Conscience, FAST, PA, SpO2 **toutes les 15 min** ; aggravation : rappeler le 15 ; arrêt : RCP + DSA.
- Heure de dernière vue normale, signes, constantes, glycémie, consignes reçues.
- **Compte rendu écrit, daté, signé**, remis au médecin (R4311-7).

À retenir : Signe neurologique brutal, même passager = 15. L'heure de dernière vue normale et la glycémie décident du traitement.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Art. R4311-7 CSP ; HAS, AVC : prise en charge précoce (mai 2009) ; ARS IDF/SGGIF fiche 12 (2016) ; ARS IDF/STARAQS fiche 12 (2023) ; ASSURE IDF fiche A (2023) ; arrêté du 26/06/2026 (art. 1 II).

Réf. DOTR-IDE-AVC | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature